

" الاضطرابات الحسية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة العقلية والأطفال العاديين دراسة مقارنة "

طاهر طارق قياتي*

Tt1134@fayoum.edu.eg

زيزي السيد إبراهيم صبره^١

هناء كارم يوسف توفيق^٢

ملخص

هدفت الدراسة الحالية إلي التعرف على الاضطرابات الحسية بين الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة العقلية والأطفال العاديين والمقارنة بين الفئات الثلاث في الاضطرابات الحسية، اعتمد الباحث على المنهج الوصفي، شملت عينة الدراسة علي (٧٢) طفل من الأطفال ذوي الإعاقات، موزعين إلي (٣١) طفل من الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، و(١٦) من الأطفال ذوي الإعاقة العقلية، و(٢٥) من الأطفال العاديين، المدي العمري لعينة البحث امتد من ٤-١١ سنة، وذلك بمتوسط عمري قدره ٦,٩٧ وانحراف معياري قدره ٢,٠٦، تم اختيار العينة من مراكز رعاية الأطفال ذوي الهمم بمحافظة القاهرة والجيزة والقليوبية، واشتملت أدوات الدراسة على مقياس البروفيل الحسي المختصر SSP ترجمة أحمد البهنساوي وزيد عبد الخالق (٢٠٢١)، وأسفرت النتائج إلي أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والأطفال ذوي الإعاقة العقلية والأطفال العاديين على مقياس البروفيل الحسي المختصر، وأن الاضطرابات الحسية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد أعلى من الأطفال ذوي الإعاقة العقلية والأطفال العاديين.

الكلمات المفتاحية: الاضطرابات الحسية/ اضطراب طيف التوحد/ الإعاقة العقلية/ الأطفال العاديين.

* باحث دكتوراة بقسم علم النفس بكلية الآداب- جامعة الفيوم.

^١ أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة الفيوم.

^٢ مدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب- جامعة الفيوم.

مدخل إلى مشكلة الدراسة:

تشهد فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وفئات ذوي الإعاقة على وجه التحديد اهتماماً كبيراً في الوقت الحالي، لم يسبق لها أن نالت مثيلاً له من قبل، وتعد دراسة مثل هذه الفئات بمثابة بوابة لمعرفة طبيعة تلك الفئات والفروق بينهم وبين الأطفال العاديين من جهة أخرى، حيث نجد أن كل طفل من هؤلاء الأطفال يعتبر في حد ذاته حالة فريدة إذ يختلف عن أقرانه في مثل سنه، وفي نفس فئته وجنسه وجماعته الثقافية، كما يختلف من جانب آخر عن الطفل العادي الذي لا يعاني من أى إعاقة بطريقة أو بآخري، وباختصار فإننا نجد أن مثل هؤلاء الأطفال الذين يعانون من إعاقة ما قد يعانون من مشكلات مختلفة في قدراتهم، وذلك في التفكير أو الإبصار أو السمع، أو الكلام أو الحركة أو الجانب الاجتماعي، أو قد تكون لديهم مواهب خاصة (عادل عبدالله، ٢٠١٠).

ونظراً لأن الحواس هي الأجهزة التي تقوم باستقبال المنبثبات الحسية من المحيط الخارجى للإنسان، وتقوم الأعصاب بدورها المتمثل بنقل هذه المعارف والاشارات العصبية من الأعصاب إلى المخ حيث يقوم المخ بترجمتها ومعالجتها ومن ثم إرسال الاستجابات عبر الحواس وهنا تتم عملية الإدراك الحسي، وعند وجود خلل حسي تظهر الاضطرابات الحسية، ويجدر بنا هنا الإشارة إلى أنه توجد بعض الدراسات التي تناولت مفهوم الاضطرابات الحسية بمسمى اضطراب المعالجة الحسية ومسمى اضطراب التكامل الحسي وتشير المفاهيم الثلاثة إلى الاضطراب العصبي الذي يسبب اعراض تدل على وجود خلل في العمليات الحسية وهو ما يدل على مفهوم الدراسة الاضطرابات الحسية، يقوم جسم

الإنسان باستقبال المدخلات الحسية حوله من صور وأصوات وملامس وروائح ومذاقات وغيرها عن طريق الأجهزة الحسية لتقوم هذه الأجهزة الحسية بتحويلها إلى رسائل كهربائية تنتقل إلى الجهاز العصبي المركزي ليقوم الدماغ بتنظيم هذه المدخلات الحسية ودمجها وتفسيرها في عملية تسمى بالتكامل الحسي، حيث كان أول من أشار إلى مفهوم التكامل الحسي هي أخصائية العلاج الوظيفي جين أريس في الستينيات من القرن الماضي (محمد أحمد، ٢٠١٥).

تعود الاضطرابات الحسية على اختلاف أشكالها إلى مشكلات في الإدراك، لذلك يهتم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ويستجيبون لمنبهات معينة ولا يستجيبون لمنبهات أخرى. فعدم القدرة على تعديل المدخلات الحسية لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد أو الإعاقة العقلية، تظهر عدم القدرة في تغيير حالات الإثارة كالدوران والحساسية الزائدة للمثيرات والكف "عدم الاستجابة"، كذلك عدم القدرة على التمييز بين المؤثرات الحسية المختلفة يؤدي إلى عدم فهمها، أو صعوبة التعرف عليها، ويتضح ذلك من خلال القصور في التعرف على أوجه الاختلاف في نواحي الشكل والحجم واللون والمسافة والصوت، وبالمثل يعاني الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من مشكلات في عمليات دمج المعلومات وهي عملية عصبية داخلية يتمكن الدماغ من خلالها دمج وتفسير التنبيه الحسي الوارد من البيئة، فالأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد صغاراً أو كباراً يعانون أحياناً من خلل أو اضطراب في نظامهم الحسي، مما يؤدي بالطفل ذوي اضطراب طيف التوحد إلى ضرب رأسه أحياناً أو الدوران حول نفسه، أو تقليب يديه، أو الركض

الهيستيري الهائج، أو الخمول وعدم الحراك أحياناً أخرى، فإذا لم يتم تنظيم هذه المعلومات الحسية فستصبح الحياة كإشارة المرور عند لحظة الذروة وهذا ما سيحدث لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، لذلك فعملية تسجيل الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد للمعلومات الحسية سليمة، وتعمل الأعضاء الحسية بشكل سليم، إلا أن المشكلة تكمن في تفسير الدماغ للرسالة الحسية، فقد يكون في بعض الأحيان تفسير مضخم لمثيرات معينة وتفسير ضعيف لمثيرات أخرى، نتيجة للخلل في عمل الدماغ، تتكون حساسية مؤلمة تجاه بعض المثيرات، ويشعر الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد أحياناً أن قماش ملابسه مثلاً الذي يلامس جسده مزعج بحيث يجعله غير قادر على التحكم في استجابته وردود فعله، وقد يكون لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد إحساس عال بأصوات معينة. لذا يلاحظ عليه أنه يغطي أذنيه بيديه. ويصرخ عند سماعه لأصوات معينة (أمين الكويتي، ٢٠١٢).

وتضيف سهى نصر (٢٠١٤) إلي أن الأطفال الذين يعانون من اضطرابات حسية يواجهون صعوبات في التحكم في ردود أفعالهم اتجاه المثيرات الحسية ويظهرون سلوكيات غير تطابقية مع شدة وطبيعة المثير.

وتضيف رحاب الرئيس (٢٠٢٠) أن ديلاني قد أوضح أن الاضطرابات الخاصة بالمعالجة الحسية هي في الأساس نتيجة لخلل في التنظيمات العصبية والتي تؤثر بدورها في معالجة الجهاز العصبي وذلك بعدة أشكال مختلفة:

- عدم قدرة المخ وعدم استطاعته على استقبال الرسائل من الناقلات العصبية.
- تناقض وتعارض الرسائل التي يقوم المخ باستقبالها.
- الرسائل المستقبلية متناغمة ولكنها غير كاملة مع بعضها من جانب ومع الحواس الأخرى كما ينبغي.

كما ذكر أحمد البهنساوي (٢٠٢٠) إلى أن نسبة قصور المعالجة الحسية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تبلغ معدلات مرتفعة، حيث تظهر في العديد من الاستجابات الخاصة بالمشاعر الحسية المختلفة، كما أنها لا تقتصر على تلك الفئة فقط، بل تبلغ نسبة انتشار الاضطرابات الحسية بين الأطفال العاديين ما بين ٥% إلى ١٠%.

ويظهر مما سبق أن مشكلة الدراسة الحالية تكمن في محاولة التعرف على الفروق انتشار الاضطرابات الحسية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة العقلية والأطفال العاديين والمقارنة بينهم لمعرفة اتجاه تلك المؤشرات، بما يعود بالنفع على الباحثين في المجال بأفكار ومقترحات بحثية تحقق النفع للمجتمع وللأفراد ذوي الإعاقات المختلفة والأطفال العاديين وذويهم ومن يقومون برعايتهم.

تساؤلات الدراسة:

مما سبق عرضه يمكن تحديد تساؤل الدراسة كما يلي:

١- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والأطفال ذوي الإعاقة العقلية والأطفال العاديين على مقياس البروفایل الحسي المختصر ؟

أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة الحالية في محاولة لتحديد الفروق في الاضطرابات الحسية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد و الأطفال ذوي الإعاقة العقلية والأطفال العاديين والمقارنة بينهم وتوفير جانب نظرى يفيد المهتمين بدراسة متغيرات ذات صلة بمتغيرات الدراسة الراهنة.

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلي:

- ١- التعرف على الاضطرابات الحسية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة العقلية والأطفال العاديين.
- ٢- معرفة هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والأطفال ذوي الإعاقة العقلية والأطفال العاديين على مقياس البروفایل الحسي المختصر.

مفاهيم الدراسة:

الاضطرابات الحسية: Sensory Disorders

عرفت مريم المطيري (٢٠١٢) الاضطرابات الحسية على أنها الخلل أو القصور في أى عضو من أعضاء الحواس (العين، الاذن، الأنف، اللسان، الجلد) أو في الخلايا العصبية المسؤولة عن توصيل المنبهات أو المتغيرات الحسية الخارجية.

وأضاف محمد أحمد (٢٠١٥) أن الاضطرابات الحسية هي صعوبة في تنظيم المعلومات الواردة أو صعوبة الإستجابة نحو المدخلات الحسية التي يتم استقبالها بواسطة الحواس السبع المعروفة، مما يؤدي إلى صعوبة تفسيرها في الدماغ، حيث يقوم جسم الإنسان بإستقبال المدخلات الحسية حوله من صور وأصوات وملامس وروائح ومذاقات وغيرها عن طريق الأجهزة الحسية (العين، الأذن، اللسان، الجلد، الجهاز الحوفي، والجهاز الدهليزي) لتقوم هذه الأجهزة الحسية بتحويلها إلى رسائل كهربائية تنتقل إلى الجهاز العصبى المركزى ليقوم الدماغ بتنظيم هذه المدخلات الحسية ودمجها وتفسيرها في عملية تسمى بالتكامل الحسى، حيث كان أول من أشار إلى مفهوم التكامل الحسى وعمل على تطويره هي أخصائية العلاج الوظيفي جين أريس في الستينيات من القرن الماضي.

ذكر عبدالله العتيبي (٢٠١٦) أن الاضطرابات الحسية هي اضطراب عصبي يسبب أعراض تدل على وجود خلل في العمليات الحسية هذه الاضطرابات لا تعود إلى وجود خلل في أعضاء الحواس، بينما الخلل يكون في

الوظائف الخاصة بالإحساس الذي يحدث في الجهاز العصبي المركزي، وتتضمن عمليات الاستقبال والتعديل والتكامل وتنظيم المثيرات، وتعرف الاضطرابات الحسية على أنها عجز أو نقص في المعالجة الذهنية العصبية لتمييز وتعديل وتفسير وتوضيح الإستجابة للمثيرات الحسية، ويمكن لاضطراب المعالجة الحسية أن يؤثر سلباً على القدرات الوظيفية والتنموية في المجالات المعرفية والحركية والشعورية والسلوكية لدى الفرد.

اضطراب طيف التوحد: "Autism Spectrum Disorders"

تعددت التعريفات التي تناولت مصطلح اضطراب طيف التوحد، وهو مصطلح يستخدم لوصف إعاقة من إعاقات النمو، والمعروف بأنه اضطراب عصبي ونمائي، يتميز الاضطراب بقصور في الإدراك وتأخر جوانب النمو والنزعة الانطوائية الانسحابية التي تعزل الطفل عن الوسط المحيط به بحيث يعيش مغلقاً على نفسه ومنعزل عن الواقع لا يكاد يشعر بما حوله من أحداث، ومن يحيط به من أفراد أو مواقف أو ظواهر (مصطفى القمش، ٢٠١١).

وقد تضمنت المعايير الحديثة لدليل التشخيص والإحصاء في طبعته الخامسة (DSM 5) توظيف لمسمى عام وموحد هو "اضطراب طيف التوحد" Autism Spectrum Disorder وتم وصفه بأنه مجموعة من اضطرابات النمو العصبي تتميز بعجز في التواصل الاجتماعي والسلوكيات النمطية التكرارية المقيدة، والتي تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، وقد ركزت المعايير الحديثة على ضرورة تحديد مستوى الدعم المطلوب، وكذلك لتشخيص اضطراب طيف التوحد لا بد من وجود أنشطة واهتمامات نمطية متكررة

وكذلك وجود اضطرابات حسية، وذلك ما لم يكن موجود في الطبعة الرابعة المعدلة، كما تضمنت تعديل للمرحلة العمرية وتوسيع للمدى العمري الذي تظهر فيه الأعراض ليشمل عمر الطفولة المبكرة والممتد حتى عمر ٨ سنوات، بدلاً عن المدى العمري من خلال المعايير القديمة وهو عمر ٣ سنوات (Lia et al., 2015).

وقد تبين أنه تم وصف هذا الاضطراب لأول مرة بواسطة الطبيب النفسي الانجيزى هنرى مودزلى ١٨٦٧م، وقد استخدم ليو كانر عام ١٩٤٣ تسمية هذه الحالات أوتيزم أو الذاتوية الطفولية ووضع وصفاً تفصيلياً لها. ولكن استخدمت كلمة التوحد لأول مرة عام ١٩٣٨ على يد هانز اسبرجر من مستشفى فيينا الجامعية (لطفى الشربيني، ٢٠١٥).

وكذلك تعددت تعريفات " اضطراب ذوي اضطراب طيف التوحد " بتعدد الاتجاهات العلمية والنظرية التى تحاول تفسير هذا الاضطراب ومن أهمها التعريف الخاص (بجمعية آباء الاطفال المصابين بالأوتيزم) في الولايات المتحدة الامريكية وهو: حالة من القصور المزمن في النمو الذي بدأ ظهور اعراضه خلال السنوات الثلاث الاولى ، ويصيب حوالي خمس أطفال من كل عشرة آلاف ولادة حية بنسبة أكبر بين الذكور عن الإناث (٤:١) ويحدث في كل المجتمعات بصرف النظر عن اللون والأصول العرقية أو الطائفية أو العنصرية أو الخلفية أو الاجتماعية ، ولم تكشف حتى الان عوامل سيكولوجية بيئية مسببة للأعاقلة بل يغلب على الظن أن العوامل المسببة ذات جذور عضوية في المخ والجهاز العصبي المركزي(فاطمة قرقار، ٢٠١٧).

يشير مصطفى القمش (٢٠١١) أن اضطراب ذوي اضطراب طيف التوحد هو عبارة عن اضطراب سلوكي يتضح في عدم القدرة على التواصل، ويبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة، وفيه يوصف الطفل بالكلام عديم المعنى وينسحب داخل ذاته وليس لديه اهتمام بالأفراد الآخرين .

ومع التقدم العلمي الهائل على كافة المستويات ظهرت أوجه جديدة للمعايير المتبعة لتشخيص وتعريف مصطلح ذوي اضطراب طيف التوحد، حيث تضمنت المعايير الجديدة للدليل التشخيصي والإحصائي في طبعته الخامسة (DSM 5) عرض لمسمى واحد هو " اضطراب اضطراب طيف التوحد وما يعرف (ASD) Autism Spectrum Disorder ويعرف بأنه مجموعة من الاضطرابات في النمو العصبي، يتميز بعجز في التواصل الاجتماعي والسلوكيات النمطية التكرارية المقيدة، وتحجث تلك الاعراض في مرحلة الطفولة المبكرة، ويتمثل تركيز المعايير الحديثة على ضرورة تحديد مستويات الدعم المطلوبة للتدخل، بالإضافة إلي وجود أنشطة واهتمامات نمطية متكررة وكذلك وجود اضطرابات حسية والتي سوف نقوم بعرض جزء توضيحي لها في ذلك الإطار (أسامة سالم، ٢٠٢١).

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلي نظرية الإدراك الحسي والتنتفسر الاضطرابات الحسية لدى الأطفال ذوي طيف التوحد.

• نظرية الإدراك الحسي:

ذكر تامر سهيل (٢٠١٥) أن تلك النظرية تقترح بأن سبب طيف التوحد إصابة في الدماغ تؤثر على واحدة أو أكثر من القنوات الحسية التي تجعل

الطفل الذى يعانى من اضطراب طيف التوحد يدرك المدخلات الخارجية بطريقة مختلفة من الطفل الطبيعى، وقد ذكر ايرس (Ayres 1989) أن كارل ديلاكتو اقترح عام ١٩٧٤ النظرية الحسية والعصبية للتوحد والتي تفسر التوحد كالتالى:

الأطفال ذوى طيف التوحد ليسوا مرضى نفسيين بل لديهم إصابة فى أدمغتهم، الإصابات الدماغية تسبب اختلالاً إدراكياً تصبح تصبح القنوات الحسية شاذة فى واحدة من التالى:

- فرط Hyper لا تكون القناة مفتوحة بشكل كاف، ونتيجة لذلك، تدخل كمية كبيرة جداً من المثيرات للدماغ، وعلى الدماغ أن يتعامل معها بشكل مريح.
 - ضعف Hypo لا تكون القناة مفتوحة بشكل كاف، ونتيجة لذلك، تدخل كمية قليلة جداً من المثيرات ويكون الماغ معاقاً.
 - الضوضاء البيضاء بحيث تخلق القناة مثيرها الخاص بها بسبب عملياتها غير الفعالة، ونتيجة لذلك تتغلب الضوضاء الموجودة فى الجهاز على الرسالة من العالم الخارجى.
 - وتعتبر السلوكيات الحسية المتكررة للطفل ذوى طيف التوحد محاولة منه لجعل القنوات الحسية المتأثرة طبيعية.
- ويجدر بنا هنا الإشارة إلى الاضطرابات الحسية لدى الأطفال ذوى طيف التوحد.

الإعاقة العقلية: Intellectual Disability

عرف ارماتس مفهوم الإعاقة العقلية على انها اضطراب وراثي يظهر فيه بشكل ملحوظ انخفاض الأداء الفكري العام عن المتوسط، ويصاحبه عجز في

السلوك التكيفي، والإعاقة العقلية حالة خاصة تبدأ في مرحلة الطفولة وهي تتميز بانخفاض درجات الذكاء ومهارات التكيف، وهو أيضاً أكثر الاضطرابات النمو شيوعاً (Armatas,2009).

عرضت سهير شاش (٢٠١٥) الرؤية التي تبنتها الجمعية الأمريكية حيث تبنت الجمعية الأمريكية للإعاقات العقلية والنمائية في عام (٢٠٠٢) تعريفاً حديثاً للإعاقة العقلية على أنها عجز يوصف بأنه قصور جوهرى وواضح في كل من الاداء الوظيفي الفكرى والسلوك التكيفي، حيث يظهر هذا العجز جلياً في المهارات التكيفية المفاهيمية، والاجتماعية، والعملية، ويبدأ هذا العجز في الظهور قبل سن الثامنة عشر، يقصد بالمهارات المفاهيمية: اللغة التعبيرية والاستقبالية، القراءة والكتابة، المفاهيم المالية، الاتجاهات الذاتية، وتشير المهارات الاجتماعية إلي معرفة التعامل مع الآخرين، تحمل المسؤولية، تقدير الذات، البساطة، إتباع النظم في الامتثال للقوانين، تنتفادى الخداع، أما المهارات العملية- فتتضمن كل من: الانشطة الشخصية مثل: الأكل، واللبس، التنقل، استخدام الحمام، ولا شك أن المهارات الاجتماعية والمهارات العلمية يرتبط بنمو المهارات المفاهيمية وفي مقدمتها اللغة التعبيرية والاستقبالية، إن هذا التعريف يؤكد على وجود القصور في كل من الجانب العقلي والتكيفي الوظيفي للفرد ذوي الاعاقة العقلية ، وتركز على أهمية البيئة وتأثيرها في تحسن أداء الفرد، وقد صاحب هذه التعريفات عدد من الافتراضات الأساسية هي :

- أن التقييم الصادق يجب أن يأخذ في الاعتبار التنوع في الجوانب الثقافية واللغوية إلى جانب الاختلافات في العوامل السلوكية، وأساليب التواصل مع الآخرين.
- أن القصور الواضح في مهارات السلوك التكيفي يجب أن يكون في إطار البيئة الاجتماعية للفرد مقارنة بأقرانه العاديين، حيث يؤدي ذلك إلى ظهور حاجات الفرد الخاصة، وبالتالي يتم التركيز عليها ودعمها.
- إن القصور في التكيف يختلف من جانب لآخر في المهارات التكيفية أو القدرات الشخصية فمقابل كل جانب قصور جانب قوة يجب مراعاته.
- إن تحسن الوظائف الحياتية للفرد ذى الإعاقة العقلية يعتمد بشكل عام على مدى توفر الدعم المناسب ولفترة محددة.

الأطفال العاديين: Typically Developing Children (Normal)

الطفولة هي حجر الأساس لبناء شخصية الإنسان مستقبلاً، وبما أنها تلعب دوراً هاماً في توافق الفرد فقد أدرك علماء الصحة النفسية أهمية دراسة مشكلات الطفولة وعلاجها في سن مبكر قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى انحرافات سلوكية، وقد أوضحت نتائج الدراسات في مجالات علم النفس المرضى دور مشكلات الطفولة في نشأة الاضطرابات النفسية والعقلية والانحرافات السلوكية في المراحل النمائية التالية (سمية جميل، ٢٠١١).

ويشير الباحث إلى أن الأطفال الأطفال العاديين هم الأطفال الذين لا يعانون من أية اضطرابات نفسية.

الدراسات السابقة:

هدفت دراسة منشو وهوبسون (Minshaw & Hobson 2008) إلى الكشف عن الإفراط والقصور في الحساسية الحسية لدى الأطفال الذين يعانون من مستويات مرتفعة من اضطراب طيف التوحد، وذلك بالإعتماد على عينة قوامها (ن=٦١) طفلاً بمتوسط عمري قدره ١٤,٤ سنة، تم استخدام استبيان الحساسية الحسية، وقد أوضحت النتائج إلى أن الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يظهرون درجة مرتفعة ذات دلالة من الإفراط في الحساسية في كل المجالات الحسية، كذلك استقرت نتائج الدراسة على أن هناك تطور تزايد للحساسية الحسية بطرق ووسائل تختلف كثيراً عن الأطفال العاديين، وأن الخلل في مجال واحد في النمو الحسي قد يؤثر على النواحي العاطفية والاجتماعية واللغوية والمعرفية.

وفي نفس السياق نجد دراسة فويب وأندرو (phoebe &Andrew, 2009) والتي هدفت إلى مقارنة أنماط العمليات الحسية لدى الأطفال العاديين والأطفال غير العاديين، تكونت عينة الدراسة ن=١٨٤٠ من الأطفال العاديين، تتراوح اعمارهم من ٣-١٠ سنوات بمتوسط عمري قدره ٧,٢٥ وانحراف معياري قدره ٢,٨، وتألقت العينة النهائية من (٩١٥) من الذكور، و (٩٢٥) من الإناث، و(ن=١٨٦) من الأطفال الغير عاديين والتي تكونت من (٧٢) من الأطفال ذوي طيف التوحد تتراوح اعمارهم من سنتان و٧ شهور إلى ١١ سنة و٦ شهور بمتوسط عمري قدره ٥,٤ وانحراف معياري قدره ٥,٤، و(١١٤) طفل من ذوي اضطراب فرط الحركة و تشتت الانتباه تتراوح اعمارهم ما بين ٤ سنوات و ٨

شهور إلي ١٢ سنة بمتوسط عمري قدره ٧,٩ وانحراف معياري قدره ١,٤، وتم استخدام تقرير استجابات الأطفال الحسية الملف الحسي الصيني، وقد اشارت النتائج إلي أن المعالجة الحسية لها دور وتأثير كبير على الاداء اليومي للمجموعتين، كما أن الأطفال الذين يعانون من ذوي الطيف الذاتوى وفرط الحركة وتشنت الانتباه لديهم مشكلات حسية بنسبة كبيرة من الأطفال العاديين، كما أسفرت نتائج الدراسة عن عدم فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين فيما يتعلق بالمشكلات الحسية والعمر.

وفي نفس العام نجد دراسة سكوين وزملاؤه (Schen et al., 2009) والتي هدفت إلي دراسة اضطراب المعالجة الحسية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وذلك لمقارنة اضطراب التكامل الحسي بين الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والأطفال ذوي اضطراب التعديل الحسي، على عينة مكونة من (٤٤ = ن) طفل، موزعين على مجموعتين (١٧) طفل من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، و (٢٧) طفل من ذوي اضطراب التعديل الحسي، وتم استخدام مقياس البروفایل الحسي المختصر SSP، وقد أشارت النتائج إلي أن الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد لديهم ضعف في الإستثارة الفسيولوجية والتفاعل الحسي، بينما كان هناك تفاعل مرتفع لدى أطفال ذوي اضطراب التعديل الحسي، كما أوضحت النتائج أن الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد لديهم حساسية مفرطة للطعم والرائحة، بينما أطفال ذوي اضطراب التعديل الحسي أبدوا سلوكيات مقبولة وقد أبدوا سلوكاً مفرطاً في طلب الأشياء.

وفي نفس السياق نجد دراسة سكوت وزملاؤه (scott et al., 2015) والتي هدفت إلي فحص العلاقة ما بين أنماط المعالجة الحسية وجوانب التنمية

السلوك التكيفي والتعبيري واللغة الاستقبالية والمهارات الحركية الدقيقة والجسمية والسلوك الاجتماعي، لدى عينة من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في سن ما قبل المدرسة، تكونت عينة الدراسة من (ن=٤٠٠) طفل من ذوي اضطراب طيف التوحد، تم استخدام قائمة استبيان للعمليات الحسية مكونة من ٣٨ عنصر لقياس المعالجة الحسية، وتشير النتائج إلى وجود علاقة بين أنماط المعالجة الحسية والمهارات التنموية، كم أن أنماط المعالجة الحسية لها تأثير على المهارات التنموية للأطفال وعلى السلوك التكيفي.

وفي نفس السياق دراسة رحاب الرئيس (٢٠٢٠) هدفت إلى تصميم برنامج إرشادي معتمد على الأنشطة الحسية لخفض مظاهر الاضطرابات الحسية لدى الأطفال من ذوي الإعاقة العقلية البسيطة، وذلك لدى عينة (ن=٥) أطفالاً ٣ من الذكور ٢ من الإناث، يتراوح المدى العمري لهم ما بين ٤:٦ سنوات كعمر عقلي، وذلك من الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات الحسية بجمعية التنقيف الفكري والتابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، تم الاعتماد على المنهج شبه تجريبي، والقائم على تصميم المجموعة الواحدة، تم استخدام مقياس ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الخامسة تقنين أ.د محمود السيد أبو النيل، مقياس الاضطرابات الحسية للأطفال تصميم الباحثة، برنامج قائم على الأنشطة الحسية تصميم الباحثة، أوضحت النتائج أنه توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال الروضة من ذوي الإعاقة العقلية البسيطة (العينة التجريبية) على مقياس الاضطرابات الحسية في القياسين القبلي والبعدي للبرنامج لصالح القياس البعدي، كما اشارت النتائج أنه لا توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي رتب أطفال الروضة من ذوي الإعاقة العقلية البسيطة (العينة التجريبية) على مقياس

الاضطرابات الحسية في القياسين البعدي والتتبعي للبرنامج مما يدل على فاعلية البرنامج الإرشادي في خفض مظاهر الاضطرابات الحسية لدى الأطفال من ذوي الإعاقة العقلية البسيطة.

كما نجد دراسة الصفا صقر وآخرون (٢٠٢٤) والتي هدفت إلى معرفة الاضطرابات الحسية ومدى تأثيرها على الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، تكونت عينة الدراسة من (ن=٥٠) طفل من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استمارة جمع البيانات إعداد الباحثة وقائمة الاضطرابات الحسية، أسفرت النتائج عن وجود الاضطرابات الحسية بشكل واضح لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وأظهرت تلك النتائج إلى الاهتمام بإنشاء وتفعيل غرف التكامل الحسي بجميع مراكز التربية الخاصة.

وفي نفس العام نجد دراسة مروة حبشي وآخرون (٢٠٢٤) وهدف إلى الكشف عن الفروق في الاضطرابات الحسية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في ضوء بعض المتغيرات (النوع، مستوى الشدة)، تكونت عينة البحث من (٣٥) طفلاً من ذوي اضطراب طيف التوحد، تراوحت أعمارهم بين (٦ : ١٠) سنوات، متوسط عمري قدره ٧,٧١ وانحراف معياري قدره ١,٤٦، وجاءت العينة من بعض المراكز المختصة بمحافظة الفيوم وبني سويف، اشتملت أدوات البحث علي مقياس جيليام الإصدار الثالث، مقياس الاضطرابات الحسية، كشفت نتائج البحث عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد علي مقياس الاضطرابات الحسية تعزي

لنوع الطفل، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد علي مقياس الاضطرابات الحسية تعزي لشدة اضطراب طيف التوحد، لصالح الفئة الشديدة من الاضطراب.

تعقيب على الدراسات السابقة:

في حدود علم الباحث لم تتناول العديد من الدراسات الاضطرابات الحسية لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية، في حين أهتمت العديد من الدراسات الأخرى بالاضطرابات الحسية لدى الأطفال ذوي طيف التوحد ولذلك كانت هناك تعقبات كالتالي:

- أهتمت الدراسات بدراسة الاضطرابات الحسية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد مثل دراسة كلاً منمروة حبشي وآخرون (٢٠٢٤)، الصفا صقر وآخرون (٢٠٢٤)، دراسة سكوت وزملاؤه (2015, scott et al.)، دراسة سكوين وزملاؤه (Schen et al., 2009)، منشو وهوبسون (Minshew & Hobson 2008).
- في حدود علم الباحث تم التوصل لدراسة تتناول الاضطرابات الحسية لدى بعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال العاديين مثل دراسة رحاب الرئيس (٢٠٢٠)، دراسة فويب وأندرو (phoebe 2009 & Andrew).

- ساهمت بعض الدراسات في إعداد برامج للتغلب على المشكلات الحسية لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن الضروري التوسع في تلك الأبحاث لمساعدة ال/ختصين في التغلب على تلك المشكلات.
- ساعدت الدراسات السابقة في تحديد أطر نظرية تساعد في دراسة الاضطرابات الحسية لدى فئات أخرى من ذوي الإعاقة.

فروض الدراسة:

مما سبق عرضه يمكن تحديد فرض الدراسة فيما يلي:

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والأطفال ذوي الإعاقة العقلية والأطفال العاديين على مقياس البروفایل الحسي المختصر.

منهج وإجراءات الدراسة:

أولاً: المنهج:

- استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي.

ثانياً: عينة الدراسة:

اشتملت العينة على (٧٢) طفل من ذوي الإعاقات والأطفال العاديين موزعين كما هو موضح في الجدول (١)، وقد تم تشخيصهم من خلال اختبار كارز لتقييم التوحد في الطفولة واختبار ستانفورد-بينيه الصورة الخامسة، كما هو

موضح فى ملفاتهم، تراوحت أعمارهم من (٤-١١) سنة، بمتوسط عمري قدره ٦,٩٧ وانحراف معياري قدره ٢,٠٦.

وكان توزيع العينة كالتالي:

جدول (١) توزيع العينة

العينة	العدد	متوسط العمر	الانحراف المعياري
اضطراب طيف التوحد	٣١	٦,٩٧	٢,٠٦
التأخر العقلي	١٦		
الأطفال العاديين	٢٥		

ثالثاً : أدوات الدراسة:

❖ مقياس الاضطرابات الحسية (البروفيل الحسي المختصر SSP) :

إعداد وبنى دان ١٩٩٩ وهو الصورة المختصرة من البروفيل الحسي الذي أعدته وبنى دان ١٩٩٧، ترجمة أحمد البهنساوى وزيد عبد الخالق ٢٠٢١، يتكون المقياس من ٣٨ بند موزعة على ٧ مقاييس فرعية هى الحساسية للمس، الحساسية للمثيرات الحسية الذوقية والشمية، الاستجابة الحسية الحركية الزائدة، الاستجابة الحسية المنخفضة، فلترة المدخلات الحسية السمعية، انخفاض الحيوية العضلية، الحساسية البصرية السمعية، ويهدف المقياس إلى تشخيص الاضطرابات الحسية على سبعة مجالات أساسية لدى الأطفال للتعرف على جوانب القصور والاضطرابات الحسية الموجودة لدى الأطفال تمهيداً لوضع تصور لخطة علاجية قائمة على نظام التكامل الحسى، ويطبق المقياس على الأطفال من عمر (٣-١٨)، وتتكون هذه النسخة المختصرة من ٣٨ بند بدلاً من ١٢٥ بنداً كما فى الصورة الكاملة، موزعة على سبعة مقاييس فرعية كالتالي:

١- الحساسية اللمسية: يقيس مدى الاستجابة الحسية للمثيرات التي تلمس الجلد ويتكون من ٧ بنود وهي ١-٢-٣-٤-٥-٦-٧.

٢- الحساسية للمثيرات الحسية الذوقية والشمية: يقيس مدى الاستجابة الحسية للطعام من حيث قوام الطعام (طعام صلب، طعام لين)، ودرجة حرارة الطعام ورائحة الطعام، ويتكون من ٤ بنود وهي ٨-٩-١٠-١١.

٣- الاستجابة الحسية الحركية الزائدة: يقيس مدى الاستجابة الحسية الحركية، والأنشطة المتعلقة بالحركة، يتكون من ٣ بنود وهي ١٢-١٣-١٤.

٤- الاستجابة الحسية المنخفضة/ السعي لزيادة التحفيز الحسى: يقيس الاستجابة الحسية المنخفضة للطفل وكذلك مدى سعيه لزيادة التحفيز الحسى، ويتكون من ٧ بنود وهي ١٥-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠-٢١.

٥- فلترة المدخلات الحسية السمعية: يقيس مدى قدرة الطفل على التركيز في حالة وجود ضوضاء محيطية، وقدرته على الاستماع الجيد للمثيرات السمعية وتمييزها، ويتكون من ٦ بنود وهي ٢٢-٢٣-٢٤-٢٥-٢٦-٢٧.

٦- انخفاض الحيوية/ الضعف العضلى: يقيس مدى قدرة الطفل العضلية ومدى تحكمه في وضعية جسده، ويتكون من ٦ بنود وهي ٢٨-٢٩-٣٠-٣١-٣٢-٣٣.

٧- الحساسية الحسية البصرية/ السمعية: يقيس مدى استجابة الطفل للمحفزات الحسية البصرية والسمعية مثل الأضواء الساطعة وصوت نباح الكلب وصوت المكنسة الكهربائية، ويتكون من ٥ بنود وهي ٣٤-٣٥-٣٦-٣٧-٣٨.

تصحيح المقياس: وتتم الإجابة على بنود الاختبار من خلال اختيار أحد البدائل الخمسة وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي وهي (أبدأ، نادراً، أحياناً، في أغلب الأحيان، دائماً) والدرجات بالترتيب كالتالي (١-٢-٣-٤-٥)، حيث تشير الدرجة المنخفضة على المقياس إلي ضعف المعالجة الحسية والعكس صحيح.

الخصائص السيكمترية للمقياس: للمقياس خصائص سيكمترية جيدة لدى أطفال التوحد، حيث كان لجميع الفقرات ارتباط إيجابي عند مستوى دلالة إحصائية (٠.٠١)، وأيضاً ارتباط البعد بالدرجة الكلية، وقد بلغت معاملات الاتساق الداخلي للبنود بالأبعاد الفرعية للمقياس ما بين (٠.٥٥٥، ٠.٨٦٠)، كذلك تم حساب ثبات مقياس البروفایل الحسى من خلال إعادة التطبيق، ومعامل ثبات ألفا كرونباخ للمقياس ككل، والتجزئة النصفية، وأسفرت النتائج جميعها عن أن للمقياس ثبات جيد مما يجعل المقياس مناسباً للبيئة المصرية في قياس الاضطرابات الحسية لدى أطفال اضطراب طيف التوحد.

كما تحقق الباحث من ثبات الاختبار باستخدام طريقة ألفا كرونباخ حيث أن معامل الثبات بلغ ٠,٩٩٤ وهو معامل مرتفع من حيث الثبات.

كما تم التحقق من صدق المقياس من خلال استخدام صدق المحك مع اختبار آخر وبلغ معامل الارتباط ٠,٩٧٥، وهو مستوي مناسب من الصدق.

رابعاً: إجراءات التطبيق:

في البداية حصل الباحث على موافقة من مراكز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمور الأطفال، وذلك للحصول على العينة المطلوبة من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة العقلية والأطفال الأطفال العاديين.

اتبع الباحث نظام التطبيق الفردي لكل حالة علي حدا مع الإستعانة بولي الأمر للاستفسار عن الاستجابات، فقد تم تطبيق مقياس البروفيل الحسي المختصر SSP في جلسة واحدة فردية لكل طفل علي حدا وذلك بتواجد ولي الأمر مع الطفل مع التشديد على ولي الأمر بعدم التدخل أو الحديث إلا عند الطلب وتوجيه السؤال إليه، وذلك للمساعدة والتأكيد على الاستجابات التي تم الحصول عليها، وذلك لضمان الوصول لأعلي درجة من المصادقية في الوصول للاستجابات عند تطبيق بنود المقياس.

خامساً: الأساليب الإحصائية:

اعتمدت الدراسة الحالية التحليلات الإحصائية باستخدام برنامج حزمة التحليلات الإحصائية للعلوم الإنسانية المعروف اختصاراً باسم برنامج SPSS.

نتائج الدراسة :

نتيجة فرض الدراسة :

ينص الفرض على أنه " توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والأطفال ذوي الإعاقة العقلية والأطفال العاديين على مقياس البروفایل الحسي المختصر " وتحققت النتائج كما يلي:

تم استخدام اختبار كروسكال_واليس لحساب الفروق بين متوسطات درجات المجموعات الثلاث الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، والأطفال ذوي الإعاقة العقلية، والأطفال العاديين على اختبار البروفایل الحسي المختصر، وتم الاستعانة بهذا الاختبار لصغر حجم المجموعات حيث أوضح الاختبار أن:

جدول (٢) متوسط رتب المجموعات الثلاث

العينه	العدد	متوسط الرتب
ذوي اضطراب طيف التوحد	٣١	٥٢,٢٧
ذوي الإعاقة العقلية	١٦	٤١,٤٤
الأطفال العاديين	٢٥	١٣,٧٨

وكانت درجات اختبار كروسكال_واليس كالتالي:

جدول (٣) درجات اختبار كروسكال_واليس للمقارنة بين متوسطات

درجات المجموعات الثلاث

قيمة مربع كاي	درجة الحرية	الدلالة
٤٨,٠٦٢	٢	٠,٠٠٠

من خلال الجدول السابق نجد أن قيمة مربع كاي المحسوبة ٤٨,٠٦٢ ويتضح من جدول درجات اختبار كروسكال_واليس لحساب الفروق بين متوسطات درجات المجموعات الثلاث الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والأطفال ذوي الإعاقة العقلية والأطفال العاديين على مقياس البروفایل الحسي المختصر SSP أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والأطفال ذوي الإعاقة العقلية والأطفال العاديين على مقياس البروفایل الحسي المختصر SSP لصالح المتوسط الأعلى وهو ما أتضح في جدول (٢) وهم الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد حسب بلغ متوسط الرتب ٥٢,٢٧ وهو أعلى متوسط في المجموعات الثلاث.

مناقشة النتائج:

أسفرت نتائج التحليل الإحصائي عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والأطفال ذوي الإعاقة العقلية والأطفال العاديين على مقياس البروفایل الحسي المختصر SSP، وتلك الفروق في صالح المتوسط الأعلى وهم الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وهذا يعنى وجود الاضطرابات الحسية وانتشارها بين الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد عن الأطفال ذوي الإعاقة العقلية والأطفال العاديين، كما أنها

تظهر لدى الأطفال الإعاقة العقلية بقدر أقل من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

وتتفق هذه النتائج مع دراسات كلاً من منشو وهوبسون (Minshew & Hobson 2008) التي هدفت إلى الكشف عن الإفراط والقصور في الحساسية الحسية لدى الأطفال الذين يعانون من مستويات مرتفعة من اضطراب طيف التوحد، وأوضحت النتائج إلى أن الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد يظهرون درجة مرتفعة ذات دلالة من الإفراط في الحساسية في كل المجالات الحسية، كذلك استقرت نتائج الدراسة على أن هناك تطور تزايد للحساسية الحسية بطرق ووسائل تختلف كثيراً عن الأطفال العاديين، وأن الخل في مجال واحد في النمو الحسي قد يؤثر على النواحي العاطفية والاجتماعية واللغوية والمعرفية، وهذا ما يتفق مع نتائج الدراسة، كذلك دراسة فويب وأندرو (phoebe 2009 & Andrew,) والتي هدفت إلى مقارنة أنماط العمليات الحسية لدى الأطفال العاديين والأطفال غير العاديين، وقد اشارت النتائج إلى أن المعالجة الحسية لها دور وتأثير كبير على الاداء اليومي للمجموعتين، كما أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب اضطراب طيف التوحد وفرط الحركة وتششت الانتباه لديهم مشكلات حسية بنسبة كبيرة من الأطفال العاديين، كما أسفرت نتائج الدراسة عن عدم فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين فيما يتعلق بالمشكلات الحسية والعمر.

كذلك تتفق نتائج دراسة الصفا صقر وآخرون (٢٠٢٤) والتي هدفت إلى التعرف على الاضطرابات الحسية ومدى تأثيرها على الأطفال ذوي اضطراب

طيف التوحد مع نتائج الدراسة، حيث أسفرت النتائج عن وجود الاضطرابات الحسية بشكل واضح لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وأظهرت تلك النتائج إلى الاهتمام بإنشاء وتفعيل غرف التكامل الحسي بجميع مراكز التربية الخاصة، وتعكس تلك المؤشرات عن وجود فروق ما بين الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والأطفال ذوي الإعاقة العقلية والأطفال العاديين في مقياس البروفایل الحسي المختصر SSP، وانتشار الاضطرابات الحسية لدى الفئات الأعلى في حساب متوسطات الرتب وهم الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ويليهم الأطفال ذوي الإعاقة العقلية وفي الأخير الأطفال العاديين.

المراجع:

- ١- أحمد البهنساوى (٢٠٢٠).فاعلية برنامج تدخل مبكر قائم على التكامل الحسى في خفض حدة الاضطرابات الحسية والإدراكية لدى عينة من أطفال التوحد، المجلة العلمية لكلية الآداب، العدد ٧٣، ص ١٠-١١٨، جامعة أسيوط.
- ٢- أسامة سالم (٢٠٢١). فاعلية برنامج تدريبي للمهات في خفض مشكلات الطعام لدى أطفالهن ذوي اضطراب التوحد، مجلة كلية التربية، كلية التربية، جامعة بنها، ١٢٧ (٣)، ٤٣٥-٤٨٨.
- ٣- أمين الكويتي (٢٠١٢). العلاقة بين الحركات النمطية والاضطرابات الحسية لدى الأطفال التوحديين في المملكة العربية السعودية، كلية الدراسات العليا، البحرين، جامعة الخليج.
- ٤- الصفا صقر، محمود اسماعيل، أحمد العمري (٢٠٢٤). الاضطرابات الحسية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد، قسم التربية البيئية، مجلة البحوث العلمية في الطفولة، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة دمنهور، ٥ (١٨)، ٢٠-٢٠.
- ٥- تامر سهيل (٢٠١٥). التوحد التعريف الأسباب والتشخيص والعلاج، دار الأعصار العلمي، الأردن.
- ٦- رحاب الرئيس (٢٠٢٠). فاعلية برنامج إرشادي قائم على الأنشطة الحسية في خفض بعض مظاهر الاضطرابات الحسية لدى الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة، المجلة العلمية لكلية رياض الأطفال، جامعة بورسعيد، العدد ١٧، ١٥٦٨-١٦٣١.
- ٧- سميرة جميل (٢٠١١). مشكلات الأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة، القاهرة، عالم الكتب.

٨- سهير شاش (٢٠١٥). تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق.

٩- سهى نصر (٢٠١٤). بناء مقياس للكشف عن اضطرابات المعالجة الحسية والتحقق من فاعليتها في عينة من الأطفال العاديين وذى اضطراب اضطراب طيف التوحد وذوي اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الحركى المفرط. مجلة الطفولة والتربية، كلية رياض الأطفال، جامعة الاسكندرية، ٦ (١٩)، ٢٨٥-٣٤٧.

١٠- عادل عبدالله (٢٠١٠). مقدمة في التربية الخاصة، القاهرة، دار الرشاد.

١١- فاطمة قرقر (٢٠١٧). الاضطرابات النفسية والضغط التي تواجه أمهات كل من أطفال الشلل الدماغي وأطفال التوحد "الأوتيزم" دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الآداب، قسم علم النفس، جامعة الفيوم.

١٢- محمد أحمد (٢٠١٥). استراتيجيات المعلمين في تنمية مهارات التكامل الحسي لتخفيف فرط الحساسية لدى أطفال اضطراب التوحد: دراسة عبر ثقافية مقارنة بين مدينتي عمان والرياض، رسالة دكتوراة، معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية، أم درمان.

١٣- مريم المطيري (٢٠١٢). مدى انتشار الاضطرابات الحسية والحركية وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية لدى الأشخاص التوحديين في دولة الكويت. رسالة ماجستير، منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة الخليج العربي، المنامة.

١٤- مروة حبشي، هبة الله أبو النيل، أحمد عزازي (٢٠٢٤). الاضطرابات الحسية لدى الأطفال ذوى اضطراب طيف التوحد في ضوء بعض المتغيرات، مجلة علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، كلية علوم إعاقة، جامعة بني سويف، ٦ (١٣)،

٢٠٤_٢٣٤.

١٥- لطفي الشربيني(٢٠١٥). دليل التعامل مع حالات التوحد، دهر العلم والايمان للنشر والتوزيع، دسوق.

١٦- مصطفى القمش (٢٠١١). الإعاقة العقلية النظرية والممارسة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.

المراجع الأجنبية:

1- Lai.,M.C, Lombardo.,M.V, Auyeung., B, Chakrabarti., B,& Baroncohen., S. (2015). Sex/gender Difereences and Autism setting The scene for Future Research. Journal of The American Academy of Child Adolescent Psyciatry, 54(1), 11-24.

2-Minshew,N. Hobson,J. (2008) Sensory Sensitivities and Performance on Sensory Perceptual Tasks in high Functioning individuals with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders,38.(8).(.)

3- Phoebe P.P.Cheung, Andrew M.H.Sia(2009): A Comparison of Sensory Processing in Children with and without Developmental Disabilities. Research in Developmental Disabilities,30.1468-1480

4- Scott D.Tomchek, Lauren M.Little, Winnie Dunn (2015) Sensory Pattern Contribution to Developmental Performance in Children with Autism Spectrum Disorder. The American Journal of occupational Therapy.69(5).(.)

5- Schen,S. Miller,L. Brett-Green,B. Nielsen,D.(2009) Physiological and behavioral differences in sensory Processing Acomparison of Children with autism spectrum disorder and sensory modulation disorder. Front Integr Neurosciv. [https:// www.nih.gov](https://www.nih.gov).

" Sensory Disturbances among Children with Autism Spectrum Disorder, Intellectual Disability, and Typically Developing children(Normal) Comparative Study"

Abstract

The current study aimed to identify Sensory Disorders among Children with Autism Spectrum Disorder, Intellectual Disability, and Typically Developing children (Normal), and to compare the three categories of Sensory Disorders. The Researcher Relied on the Descriptive approach. The study sample included (72) Children with disabilities, distributed into (31) Children suffering from Autism Spectrum Disorder, (16) Children with Intellectual Disability, and (25) Typically Developing children (Normal). The Age range of the Research sample extended from 4-11 years, with an average age of 6.97 and a standard deviation of 2.06. The sample was selected from care centers for children with disabilities in the Governorates of Cairo, Giza, and Qalyubia. The study tools included the Short Sensory Profile Scale (SSP), translated by Ahmed Al-Bahnsawy and Zaid Abdel-Khaleq (2021). The results showed that there are statistically significant differences between the average scores of Children with Autism Spectrum Disorder, Children with Intellectual Disability, and Typically Developing children (Normal).on the Short Sensory Profile Scale, and that Sensory Disorders among Children with Autism spectrum Disorder is more prevalent in Children with Intellectual Disabilities and Typically Developing Children (Normal).

Keywords: Sensory Disorders / Autism Spectrum Disorder / Intellectual Disability.